

Información Paciente

Nombre : América Valeria Espíndola Rubio
Edad : 29a 4m 8d
Dirección : Río Coya 611 Dpt 103

Rut : 18.128.712-8
Fecha Nacto: 07/11/1992
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1511288
Sexo : Femenino
Teléfono : 930256442

N° Epicrisis
299010

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Recuperación

Fecha Ingreso : 06/03/2022 06:25

Días Estadía : 9

Unidad de Egreso : Ginecología (4° Piso)

Fecha Egreso : 15/03/2022 12:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

- M1 CCA
- Óbito fetal 34 sem Obs DPPNI
- PES vs Eclampsia
- Obesidad

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

- Mórbidos: Fractura 3er MTC con manejo ortopédico, depresión con intento de autolisis en 2015, fractura 5° MTT izquierdo de manejo ortopédico en 2017, TEC simple en 2019, ITU durante embarazo, Obesidad, Obs VIF
- Quirúrgicos: 1 CCA
- Medicamentos: (-)
- Tabaco: no OH: no Drogas: no
- Alergias: diclofenaco y cefadroxilo.
- Inmunizaciones: COVID 2 dosis, influenza (+), dTPa (+)

- GO: G2P1, cesárea por sufrimiento fetal agudo y RCIU (2011: 39 sem, 2380 g) , FUR: 11/07/2021

HISTORIA ACTUAL:

Paciente ingresa cursando su 2° embarazo, de 34 semanas, de evolución fisiológica salvo hospitalización reciente por ITU baja tratada con cefadroxilo y posteriormente con Nitrofurantoína con buena respuesta.

Consulta en SU de maternidad CASR por dinámica uterina de 24 h de evolución que se exacerba desde las 23:00 h del día previo. Control de signos vitales muestra PA a la 3a toma de 141/98 mm Hg asociado a fotopsias (+). Tinitus (-), cefalea (-), visión borrosa (+). Disminución de movimientos fetales.

Ecografía obstétrica general hecha a su ingreso describe: feto en cefálica, sin LCF, tampoco con flujo al doppler color. Se realiza amniocentesis diagnóstica.

Ingresa a pabellón con anestesia raquídea. Se realiza Laparotomía de Pfannenstiel observando óbito y placenta desprendida totalmente. Se administra: Ac. tranexámico, misotrol 600 mg vía rectal y 400 mg SL, methergin 1 amp IM. Inicia BIC de Sulfato de magnesio y labetalol. Útero sin capacidad de retracción, con sangrado en Napa. Se realiza sutura de B-Lynch. Pérdida estimada de sangre 2000 cc. Balance transfusional GR5 PLQ 16 Crio 10 PFC 8, con BHA +6800

A las 12:30 06/03 es intubada vía orotraqueal por compromiso de conciencia y movimientos corporales involuntarios, interpretados como convulsión. Queda conectada a máquina de anestesia y posteriormente se traslada a UCI. TAC de cerebro

Fecha Epicrisis : 15/03/2022 13:57

Fecha Última Actualización: 15-03-2022 13:57:13

Página 2 de 4

sin alteraciones

EXAMENES DE INGRESO

05/03: Creatinina 1.55 mg/dl; HTO/Hb 33.7/11.4; PLQ 119.000, TP 19%, INR 3.7, TTPK 40.2, LDH 910 Con GOT 46 y GPT 13.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- M1 CCA
- Óbito fetal 34 sem Obs DPPNI
- PES vs Eclampsia
- Obesidad

Exámenes de laboratorio

- 11/03 : Hb 8.7/Hcto 25.6/ GB 14600/ Plq 219000/ AU 8.7/ Alb 2.9/ GOT 48/ GPT 6 / GGT 42/ Ca 8.5 / BiliT 0.37/ Crea 1.56/ BUN 29.9/ P 4.4/ LDH 682/ PCR 134.3/ TP 10.8/ TTPA 24.5/ ELP 135/4.02/105 proteinuria 24h: 1.13g.
- 12/03: pH 7.4 PCO2 30 PO2 42.7 BIC 18.4 EBT -5.3 Hcto/Hb: 27.3/9.0 Leuc 10480 PCR 97.4 Plaqt 273.000 ELP 139/3.88/108 Alb 3.2 FA 86 GGT 29 GOT/GPT 41/9 Ca 8.8 Creat 1.26 P 3.5 LDH 559
- 14/03: pH 7.47 PCO2 34.8 PO2 75 HCO3 24.9 EB 1.3 ELP 142/3.38/110 FA 68 GGT 31 GOT/GPT 21/8 Creat 0.82 BUN 13.1 LDH 408 PCR 52 Hcto/Hb 27.2/9.0 Leuc 8.32 Plaqt 351.000

Evolución UCI

Hemodinamia: Hemodinámicamente con requerimientos de labetalol para control de presiones para PAM 70-90. Se suspende el 09/03 y se inicia losartán/hidralazina/isosorbide, se evidencia caída inicial de hcto que posteriormente se estabiliza, sin más transfusiones. Se mantiene con sulfato de magnesio en infusión por 24 hrs. Posteriormente se suspende sedación, no presenta nuevos episodios sospechosos de comicialidad.

Respiratorio: Se logra paso a PSV y se extuba el 08/03, con necesidad de CNAF con alto soporte, con ecoscopía pulmonar con signos congestivos. Se logra BH negativo y consecuentemente se logra disminuir apoyo CNAF hasta 35 L y luego ventana de naricera el 11/03 bien tolerada. Actualmente sin requerimientos de oxígeno.

Nefrológico/Medio Interno: Cursa con falla renal (crea hasta 4.3), no oligúrica, IPC 300, proteinuria 2.59 g en 24 hrs, sin urgencia dialítica, con recuperación progresiva en días posteriores. Último control de creatinina 0.8 14/03

Ginecológico/Obstétrico: Se sospecha Sd de HELLP contexto de síndrome HELLP por falla renal y plaquetopenia, LDH ingreso 910, no cursa con alteración de enzimas hepáticas. Se solicita Ecoabdomen sugerida por Obstetricia, sin lesiones. Posteriormente normalización de recuento plaquetario y pruebas de coagulación, por lo que puede iniciar tromboprofilaxis con HNF, descenso progresivo de LDH.

- Recibe Cabergolina 1 mg para supresión de lactancia el día 8/03

Rehabilitación: Inicia alimentación tras evaluación por fonoaudiología. Caminando con Kine.

Infeccioso: Sin conflicto infeccioso: cultivo líquido amniótico (-), CAET (-)

DIAGNÓSTICOS DE TRASLADO

- Eclampsia
- Sd. de Hellp incompleto
- Puérpera reciente de cesárea
- Inercia uterina
- Óbito fetal por DPPNI
- Obesidad

15-03-22 paciente es trasladada a ginecología con diagnosticos

1. Puérpera 8º día de cesárea de urgencia
- PES /DPPNI / Óbito fetal / Inercia uterina
2. Eclampsia
3. Sd. de Hellp incompleto
4. Obesidad

Evolución en puerperio

Paciente en su día 8 de puerperio en buenas condiciones generales, asintomática, cardiopulmonar estable, afebril, abdomen herida seca utero retraído, genitales loquiso escaso reflejos normales, masmas sin signos de infección,

Fecha Epicrisis : 15/03/2022 13:57

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 15-03-2022 13:57:13

Página 3 de 4

cifras tensionales fuera de rango de crisis , en tratamiento Amlodipino 10 mg/día VO + Hidralazina 50 g c/8 h VO + Isosorbide 10 mg c/8 h VO

En vista de paciente asintomtica se indica alta medica y seguimiento por medicina interna y paro para resultado de estudios.

Diagnósticos de egreso:

M1 CCA

Puérpera 8º día de cesárea de urgencia

- Óbito fetal 34 semanas

- DPPNI

- PE con criterios de severidad - Hellp incompleto - eclampsia

- Inercia uterina - B Lynch

Anemia moderada - shock hemorrágico recuperado

- Politransfundida.

AKI en resolución

Obesidad

Diagnóstico de Egreso

Eclampsia - Sd Hellp Incompleto

Shock Hipovolemico - Shock Hemorrágico - Inercia Uterina, Desprendimiento De Placenta

Obito Fetal -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en su día 8 de puerperio en buenas condicones gnerales, asintomtica, cardiopulmonar estable, afebril, abdomen herida seca utero retraido, genitales loquiso escaso relfejos normales,masmas sin signops de infeccion, cifras tensionales fuera de rango de crisis , en tratamiento Amlodipino 10 mg/día VO + Hidralazina 50 g c/8 h VO + Isosorbide 10 mg c/8 h VO

En vista de paciente asintomtica se indica alta medica y seguimiento por medicina interna y paro para resultado de estudios.

Plan Post Alta

Reposo relativo

Régimen hiposódico

Seguimiento por hospitalización domiciliaria para toma de presiones arteriales diaria hasta control en PARO.

Control con medicina interna. Se realiza IC. Seguimiento por equipo.

Control con nefrología. Se realiza IC. Seguimiento por equipo

Control con Psiquiatria.Se realiza IC. Seguimiento por Equipo

Acudir a consultorio para seguimiento en programa de salud mental

Toma de exámenes de laboratorio en una semana. Se entrega orden

Pendiente rescatar resultado de biopsias y autopsia fetal

Control en 10 días en PARO con resultado de exámenes de laboratorio. Se solicita hora:

De forma posterior a control, debe acudir a nuevo control en PARO en 5 semanas. Considerar solicitar exámenes de control generales, SAAF, estudio de trombofilias, proteinuria 24 hrs 6 semanas post cesarea, ecocardio en 6 meses

Medicamentos. Mantener hasta próximo control médico:

- Amlodipino 10mg al día via oral

- Hidralazina 50 mg cada 8 horas via oral

- Isosorbide 10 mg cada 8 horas via oral

- Omeprazol 20 mg al día via oral por 10 días

- Enoxaparina 40 mg al día SC por 6 semanas

- Dulcolax 1 perla cada 12 horas via oral en caso de constipación

- Paracetamol 500mg, 2 comprimidos cada 8 horas via oral por 3 dias

Control SOS en caso de sintomas de alarma

Dr Sandoval / Dr Godoy / Dra Arce / Dra Hierard

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Fecha Epicrisis : 15/03/2022 13:57

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:48

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 15-03-2022 13:57:13

Página 4 de 4

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO


Carmen Paz Arce Fontecilla
Becado/Residente

Bella García Azuaje
Médico Tratante (Staff)